UNIDADE DE EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA E HEMODINÂMICA — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-001)

Laudo Clínico e Prontuário de Internação: Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento de ST

ID Prontuário:	**DOC-MED-001**	**Paciente:**	**P-01 (Carlos Eduardo Mendes)**	**Idade / Sexo:**	68 anos | Masculino
Antropometria:	84 kg | 1,72 m (IMC: 28,4 kg/m²)	**Data/Hora:**	10/11/2026 - 06:40h	**Código CID-10:**	**I21.0 (Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio)**

Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia): Diagnóstico Canônico: Infarto Agudo do Miocárdio (Aliases: IAM, Ataque Cardíaco, Síndrome Coronariana Aguda). Fármacos: Ácido Acetilsalicílico (Aliases: AAS, Aspirina), Clopidogrel (Aliases: Plavix, Bissulfato de Clopidogrel). Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (Aliases: HAS, Pressão Alta).

1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente masculino, 68 anos, aposentado, deu entrada no pronto-socorro cardiológico trazido pelo serviço de atendimento móvel de urgência com quadro de dor torácica retroesternal típica, de caráter opressivo ("em aperto"), iniciada em repouso há aproximadamente 120 minutos. A dor apresentava intensidade 9/10 na escala visual analógica, com irradiação clássica para a face medial do membro superior esquerdo, região cervical e mandíbula, acompanhada de sudorese fria profusa (diaforese), palidez cutâneo-mucosa, náuseas e dispneia aos mínimos esforços.

Nos antecedentes pessoais patológicos, o paciente apresenta diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS / Pressão Alta) há 18 anos com adesão irregular ao tratamento medicamentoso domiciliar, além de dislipidemia mista e carga tabágica acumulada de 40 maços-ano. Nega alergias medicamentosas conhecidas, mas relata pirose ocasional automedicada com antiácidos comuns.

2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

Parâmetro Clínico / Exame de Imagem	Achados Objetivos e Descrição Propedêutica
Sinais Vitais na Admissão	PA: 168/104 mmHg | FC: 108 bpm | FR: 24 irpm | SpO2: 91% em ar ambiente | Temp: 36,4 °C
Ausculta Cardíaca	Ritmo cardíaco regular em 3 tempos (presença de quarta bulha - B4), bulhas normofonéticas, sem sopros valvares audíveis. Turgência jugular patológica discreta a 45°.
Ausculta Pulmonar	Murmúrio vesicular presente bilateralmente, com estertores crepitantes finos em bases pulmonares (Classificação de Killip-Kimball II).
Eletrocardiograma (ECG 12 derivações)	Ritmo sinusal taquicárdico com supradesnivelamento convexo do segmento ST de 4,5 mm nas derivações precordiais V1 a V4 e D1/aVL, configurando corrente de lesão subepicárdica extensa em parede anterolateral.

3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

Exame / Biomarcador Analisado	Resultado Obtido no Paciente	Valor de Referência / Interpretação
Troponina I Ultrassensível (Admissão / 3h)	**1.420 ng/L -> 8.950 ng/L**	< 14 ng/L (Positivo Crítico)
CK-MB Massa	**64,8 ng/mL**	< 5,0 ng/mL (Elevado)
Colesterol LDL / HDL	**178 mg/dL / 32 mg/dL**	LDL < 50 mg/dL (Alto Risco)
Creatinina Sérica / TFGe	**1,18 mg/dL (TFGe: 64 mL/min)**	0,7 - 1,2 mg/dL
Glicemia de Admissão / HbA1c	**134 mg/dL / 6,1%**	70 - 99 mg/dL
Plaquetas / RNI	**245.000 /mm³ | RNI: 1,04**	150.000 - 450.000 /mm³

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

O evento agudo decorre da ruptura de placa aterosclerótica vulnerável no terço proximal da Artéria Descendente Anterior (ADA), com formação de trombo oclusivo rico em plaquetas e fibrina. Os fatores etiológicos primários identificados são a

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) crônica não controlada — que promove estresse de cisalhamento endotelial — associada ao estresse oxidativo vascular induzido pelo Tabagismo Crônico e hipercolesterolemia LDL.

5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Reperfusão Mecânica Imediata: Paciente encaminhado em caráter de emergência (tempo porta-balão de 52 minutos) ao laboratório de hemodinâmica, sendo submetido a Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) com implante de Stent Farmacológico em Artéria Descendente Anterior sob administração de 140 mL de Meio de Contraste Iodado não-iônico.

2. Dupla Antiagregação Plaquetária (DAPT): Ataque de Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina) 300 mg mastigados seguido de manutenção de 100 mg/dia VO, combinado com dose de ataque de Clopidogrel (Plavix) 600 mg VO seguido de manutenção de 75 mg/dia VO por no mínimo 12 meses.

3. Terapia Adjuvante: Atorvastatina 80 mg/dia (estatina de alta potência), Enalapril 10 mg 12/12h e monitoramento em Unidade de Terapia Intensiva Coronariana.

[ALERTA DE GRAFO KAG - INTERAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO CRUZADA]:

• Risco de Trombose de Stent (Conexão com DOC-MED-002): O antiagregante plaquetário Clopidogrel (Plavix) é um pró-fármaco que depende obrigatoriamente da biotransformação hepática pela enzima citocromo CYP2C19 para se tornar ativo. A prescrição concomitante do protetor gástrico Omeprazol (Losec) — frequentemente usado em Úlcera Péptica Gástrica — promove inibição competitiva da enzima CYP2C19, reduzindo em até 45% a eficácia antiplaquetária do Clopidogrel e precipitando oclusão aguda do stent coronariano.

• Risco de Hemorragia por Salicilatos (Conexão com DOC-MED-002 e DOC-MED-004): O uso contínuo de Ácido Acetilsalicílico (AAS) agride a barreira mucosa gástrica, atuando como fator causal direto para Úlcera Péptica Gástrica (DOC-MED-002), além de ser estritamente proibido em quadros virais trombocitopênicos como a Dengue Clássica (DOC-MED-004).

• Risco Renal por Contraste Iodado (Conexão com DOC-MED-005): O procedimento de Angioplastia Coronariana utiliza Meio de Contraste Iodado endovenoso, o qual interage severamente com o antidiabético Metformina (Glifage), podendo desencadear Acidose Lática fatal em pacientes com Nefropatia Diabética Crônica.

Autenticação Digital: Junta Médica de Suporte à Decisão Clínica (GraphRAG & KAG Healthcare) | Registro DOC-MED-001 — Validação Completa.